

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

MAS · ESCALA DE MANÍA DE BECH-RAFAEALSEN

Bech-Rafaelsen Mania Scale (BRMS) – Patrón de referencia heteroaplicado de 11 ítems para cuantificar estados de euforia e hipomanía

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Bech-Rafaelsen Mania Scale (MAS / BRMS)
Autores Originales	Per Bech, O. J. Rafaelsen, P. Kramp y T. G. Bolwig (1978, 1979)
Validación Española	Banco de Instrumentos Básicos de Psiquiatría Clínica de Bobes et al. (2004)
Tipo de Instrumento	Escala clínica de entrevista semiestructurada heteroaplicada
Población Diana	Pacientes adultos con Trastorno Bipolar en fase hipomaniaca, maniaca o mixta
Tiempo de Aplicación	12 a 18 minutos (cumplimentada por clínico entrenado)
Formato de Respuesta	Escala tipo Likert clínica de 5 niveles: 0 (Ausente) a 4 (Máxima gravedad)
Finalidad Clínica	Cuantificación dimensional de la severidad del episodio maniaco y medición precisa de la eficacia anti-maniaca de estabilizadores del ánimo y antipsicóticos

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

En la psicopatología cuantitativa escandinava, Per Bech y Ole Rafaelsen buscaron construir una escala análoga a la Escala de Depresión de Hamilton pero con propiedades métricas puramente monotónicas para la manía. A diferencia de las conceptualizaciones que incluyen síntomas psicóticos polimorfos o esquizoafectivos, la MAS se concentra en el núcleo psicomotor y afectivo primario de la activación maniaca.

El modelo teórico asume que la manía se sustenta en una hiperactivación neurobiológica central que acelera paralelamente tres esferas: la actividad motora, la velocidad del procesamiento mental y el tono hedónico expansivo. Los 11 reactivos de la escala exploran la actividad física, la verborrea, la fuga de ideas, la euforia patológica, los delirios de grandeza, la hostilidad/beligerancia, la desinhibición sexual, la reducción de la necesidad de sueño y la pérdida del autocontrol social.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Núcleo Sintomático	Nº Ítems	Ítems Constituyentes y Manifestaciones Evaluadas
Hiperactividad Motora y Verbal	3 ítems	Ítem 1 Actividad motora (inquietud física), Ítem 2 Velocidad verbal (verborrea continua), Ítem 3 Fuga de ideas y aceleración del pensamiento.
Ánimo Expansivo y Conducta	3 ítems	Ítem 4 Humor elevado / euforia, Ítem 5 Autoestima inflada y grandiosidad, Ítem 6 Hostilidad, agresividad y beligerancia verbal/física.
Desinhibición Hedónica y Ruido	3 ítems	Ítem 7 Interés y actividad sexual desinhibida, Ítem 8 Ruido y conducta social perturbadora, Ítem 11 Contacto social intrusivo.
Sueño y Fatigabilidad	2 ítems	Ítem 9 Reducción de la necesidad biológica de sueño, Ítem 10 Cansancio o fatiga subjetiva ausente.
Puntuación Total MAS	11 ítems	Suma global de los 11 reactivos (Rango: 0 a 44 puntos).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · MAS

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Consistencia Interna	Alfa de Cronbach = 0.88 a 0.91 en cohortes clínicas bipolares en Europa y España (Bech et al., 1979; Bobes et al., 2004).
Fiabilidad Inter-Jueces	Excelente correlación intraclase (ICC = 0.90 a 0.95) entre psiquiatras evaluadores; los anclajes definidos previenen discrepancias diagnósticas.
Validez Concurrente	Correlación muy elevada con la Young Mania Rating Scale (YMRS, $r = 0.89$), con la escala CARS-M/EVMAC ($r = 0.86$) y con la CGI-Manía ($r = 0.84$).
Sensibilidad Farmacológica	Capacidad contrastada para detectar descensos terapéuticos significativos en las primeras 48-72 horas tras el inicio de tratamiento antipsicótico agudo.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

- Calificación Heteroaplicada de 0 a 4:** Cada ítem se puntúa de 0 a 4 puntos con anclajes descriptivos específicos en cada nivel:
 - 0 = Ausente; 1 = Dudoso / ligero aumento; 2 = Moderado; 3 = Grave / marcado; 4 = Extremo / incapacitante.
- Puntuación Total:** Suma simple directa de los 11 ítems.
- Rango de Puntuación:** De 0 a 44 puntos posibles.
- Criterio Estándar de Remisión Clínica:** Puntuación total en MAS ≤ 5 puntos.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación MAS	Estratificación	Estado Afectivo	Directriz Asistencial y Farmacológica
0 a 5 puntos	Eutimia / Remisión	Asintomático	Mantenimiento preventivo con estabilizador del ánimo.
6 a 9 puntos	Hipomanía	Activación Leve	Ajuste ambulatorio; suprimir antidepresivos y regular sueño.
10 a 14 puntos	Manía Leve	Desinhibición Clara	Optimización farmacológica oral; control familiar estrecho.
15 a 20 puntos	Manía Moderada	Afectación Funcional	Hospital de día o intensificación terapéutica urgente.
≥ 21 puntos	Manía Grave / Severa	Extrema / Hostil	Ingreso hospitalario en Unidad de Agudos de Psiquiatría.

PUNTO DE CORTE DE MANÍA CLÍNICA (MAS ≥ 15): Una puntuación igual o mayor a 15 puntos indica un episodio maníaco pleno con grave riesgo de conductas desadaptadas y colapso psicomotor, justificando formalmente la adopción de medidas de internamiento y contención farmacológica inmediata.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · MAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Entrevista Heteroaplicada de Evaluación: Observar conducta del paciente en consulta y recabar informe familiar.

Paso 2: Conducta Terapéutica Asistencial:

- **Si MAS 0-5:** Remisión confirmada. Mantener litemia entre 0.6 y 0.8 mEq/L.
- **Si MAS 6-9 (Hipomanía):** Suspender de inmediato inhibidores de la recaptación de serotonina u otros estimulantes; pautar benzodiacepinas nocturnas (clonazepam 1-2 mg) para restaurar ciclo de sueño.
- **Si MAS $\geq$ 15 (Manía Moderada a Grave):**
 1. Instaurar terapia combinada: Estabilizador (Litio o Valproato sódico) + Antipsicótico de segunda generación (Olanzapina 10-20 mg/d o Aripiprazol 15-30 mg/d).
 2. Evaluar hostilidad (ítem 6 $\geq$ 3): valorar ingreso involuntario si existe agresividad o negativa al tratamiento.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Varón de 34 años, empresario de hostelería con diagnóstico de Trastorno Bipolar I, acude acompañado por su esposa tras 5 noches durmiendo apenas 2 horas por noche, manteniendo compras desmedidas y proyectos comerciales grandiosos irreales.

Evaluación Psicométrica Inicial en MAS: Total = 27 / 44 puntos (Manía Grave / Severa).

- **Hiperactividad y Lenguaje:** Inquietud motora continua levantándose del asiento (ítem 1 = 3); habla imparable y atropellada (ítem 2 = 3); asociaciones laxas y fuga de ideas marcada (ítem 3 = 3).
- **Afecto y Grandiosidad:** Risa expansiva e ironía hiriente (ítem 4 = 3); planes de fundar una cadena hotelera internacional sin capital (ítem 5 = 4); hostilidad ante las contradicciones de su cónyuge (ítem 6 = 3).
- **Sueño:** Duerme 2 horas sin acusar fatiga al día siguiente (ítem 9 = 4).

Intervención Hospitalaria: Dada la gravedad psicomotriz y la hostilidad reactiva, se tramitó ingreso voluntario en la Unidad de Agudos de Psiquiatría. Se inició valproato sódico oral (1500 mg/día) asociado a olanzapina (15 mg/día). A los 7 días de tratamiento, la MAS se redujo a 12 puntos; y a las 3 semanas alcanzó 4 puntos (remisión clínica completa), recuperando el insight sobre sus proyectos comerciales desmedidos y restableciendo el ritmo de sueño habitual.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS CRÍTICAS DE RIESGO

- Una puntuación de 3 o 4 en Hostilidad (ítem 6) es predictor de incidentes violentos físicos inmediatos; evitar confrontación directa.
- La falta de sueño prolongada (> 72 horas) induce estados confusionales y rabdomiólisis por esfuerzo físico ininterrumpido.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Episodio Mixto:** Coexistencia de aceleración motora con disforia, llanto y desesperanza; elevado riesgo de suicidio impulsivo.
- **Psicosis Esquizofrénica:** La desorganización conceptual domina sobre el humor expansivo contagioso característico de la manía.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Bech, P., Rafaelsen, O. J., Kramp, P., & Bolwig, T. G. (1978). The mania rating scale: Scale construction and inter-observer agreement. *Neuropharmacology*, 17(6), 430–431.
- Bech, P., Bolwig, T. G., Kramp, P., & Rafaelsen, O. J. (1979). The Bech-Rafaelsen Mania Scale and the Hamilton Depression Scale: Evaluation of homogeneity and inter-observer reliability. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 59(4), 420–430.
- Bech, P. (2002). The Bech-Rafaelsen Mania Scale (MAS): 20 years of clinical experience. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 106(Suppl 415), 1–7.
- Bobes, J., García-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Médica.